

Femancia

"Để xa tám tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

THÀNH PHẦN, CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nang cứng chứa:

- Thành phần hoạt chất: Sắt fumarat.....305mg
Tương ứng sắt..... 100mg
Acid folic.....350mcg

- Thành phần tá dược: Lactose; Tinh bột sắn; Gelatin; Natri lauryl sulfat; Bột talc; Magnesi stearate; Nước tinh khiết.

DẠNG BAO CHẾ

- Viên nang cứng

- Mô tả: Viên nang cứng số 0, màu đỏ, nang không nứt vỡ, không móp méo. Bên trong chứa bột thuốc màu nâu.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị các trường hợp thiếu máu do thiếu cung cấp hoặc mất chất sắt và các yếu tố tạo máu.
- Các trường hợp tăng nhu cầu tạo máu như ở phụ nữ có thai, cho con bú, người suy dinh dưỡng, thời kỳ hậu phẫu, giai đoạn phục hồi sau bệnh nặng.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

- Dùng thuốc tốt nhất khi bụng đói, có thể dùng với thức ăn để giảm khó chịu đường tiêu hóa.
- Người lớn uống 1 viên/ngày trước khi ăn.
- Trẻ em: Không khuyến cáo sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, chứng nhiễm sắc tố sắt, loét dạ dày tiến triển, truyền máu lặp lại, viêm ruột non từng vùng, viêm loét đại tràng, thiếu máu không do thiếu sắt.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Sắt fumarat:

- Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh có nguy cơ loét dạ dày, viêm ruột hồi hoặc viêm loét ruột kết mạn.
- Thời gian điều trị thiếu máu do thiếu sắt không nên vượt quá 6 tháng. Do thiếu máu do thiếu sắt kết hợp và Vitamin B₁₂ hoặc thiếu chất folat có thể là bệnh thiếu vi lượng, bệnh nhân thiếu máu thiếu cầu không dung nạp với điều trị bằng sắt nên được kiểm tra xem có thiếu Vitamin B₁₂ hay folat hay không.

Acid folic:

- Không được dùng acid folic riêng biệt hay dùng phối hợp với Vitamin B₁₂ với liều không đủ để điều trị thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ chưa chuẩn đoán được chắc chắn. Các chế phẩm đa vitamin có chứa acid folic có thể nguy hiểm vì che lấp mức độ thiếu thực sự Vitamin B₁₂ trong bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu Vitamin B₁₂.
- Mặc dù acid folic có thể gây ra đáp ứng tạo máu ở người bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu Vitamin B₁₂ nhưng vẫn không được dùng nó một cách đơn độc trong trường hợp thiếu Vitamin B₁₂ vì nó có thể thúc đẩy thoái hóa tủy sống bán cấp.
- Cần thận trọng ở người bệnh có thể bị khó u phụ thuộc folat.
- Thuốc có chứa lactose: Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, chứng thiếu hụt lactase Lapp hoặc rối loạn hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.
- Người có lượng sắt trong máu bình thường tránh dùng thuốc kéo dài. Ngưng dùng thuốc nếu không dung nạp.

Khuyến cáo:

- Khi thấy thuốc bị mốc, nhãn thuốc in số 0 SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hội lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

Khí nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:

- Khi cần thêm thông tin về thuốc xin hỏi ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ.
- Khi thấy có những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Khi dùng thuốc mà thấy triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Thuốc dùng được cho đối tượng này

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

- Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Sắt fumarat:

- Không phối hợp thuốc với các thuốc kháng sinh như: Ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin.
- Uống đồng thời thuốc với các thuốc kháng acid như calci carbonat, natri carbonat và magnesi trisilicat hoặc với nước chè có thể làm giảm hấp thu sắt.
- Sắt có thể chelat hóa với tetracyclin và làm giảm hấp thu của cả hai loại thuốc.
- Sắt có thể làm giảm hấp thu của penicilamin, carbidopa/ levodopa, methylodopa, các quinolon, các hormon tuyến giáp và các muối kẽm.

Acid folic:

- Hấp thu của thuốc có thể bị giảm khi dùng thuốc đồng thời với sulphasalazin.
- Các thuốc tránh thai đường uống làm giảm chuyển hóa của folat và gây giảm folat và Vitamin B₁₂ ở một mức độ nhất định.
- Cotrimoxazol làm giảm tác dụng điều trị thiếu máu nguyên hồng cầu của acid folic.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

- Đường tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, nôn, táo bón. Phân đen (không có ý nghĩa lâm sàng).

- Da: Ngứa, nổi ban, mẩn ngứa.

Hướng dẫn cách xử trí ADR:

- Có thể hạn chế các ADR không thường xuyên bằng cách uống liều thấp, sau tăng dần
- Tuy nhiên khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

- Triệu chứng quá liều: Dùng sắt quá liều có các dấu hiệu ngộ độc như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy kèm ra máu, mất nước, nhiễm acid và sốc kèm ngất gâ. Lúc này có một giai đoạn tưởng như bình phục, không có triệu chứng gì, nhưng sau khoảng 6-24 giờ các triệu chứng xuất hiện lại với các bệnh đông máu và suy tim mạch (suy tim do thương tổn cơ tim). Một số biểu hiện như: Sốt cao, giảm glucose huyết, nhiễm độc gan, suy thận, cơn co giật và hôn mê. Để có nguy cơ tử vong ruột nếu uống liều cao. Trong giai đoạn hồi phục có thể có xơ gan, hẹp môn vị. Cũng có thể bị nhiễm khuẩn huyết do *Yersinia enterocolica*.
- Điều trị: Rửa dạ dày bằng sữa hoặc dung dịch carbonat. Sau khi rửa dạ dày, bơm dung dịch deferoxamin vào dạ dày qua ống thông. Trong trường hợp lượng sắt dùng trên 60mg/kg cân nặng, hoặc khi có triệu chứng nặng, đầu tiên phải cho deferoxamin tiêm truyền tĩnh mạch. Liều tiêm truyền tĩnh mạch 15mg/kg/giờ đến khi hết triệu chứng và tới khi nồng độ Fe³⁺ giảm dưới mức 60 micromol/lit. Cần thiết có thể dùng liều cao hơn. Nếu cần nâng cao huyết áp dùng dopamin, thẩm phân nếu có suy thận. Điều chỉnh cân bằng acid base và điện giải, đồng thời bù nước.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

- Nhóm dược lý: Khoáng chất và chất điện giải. Nhóm tạo màu dạng kết hợp.
- Mã ATC: B03AD02.
- Sắt fumarat: Dạng có hàm lượng sắt cao (33 yếu tố quan trọng tham gia vào cấu tạo Hemoglobin và quá trình oxy hóa các mô sống) là một thành phần của huyết sắc tố, có nhiều nghiên cứu ủng hộ giả thuyết rằng việc thiếu chất sắt có ảnh hưởng bất lợi đến khả năng học tập và khả năng giải quyết các vấn đề trẻ em tuổi còn học. Trẻ em thiếu máu được điều trị bằng chất sắt làm gia tăng tỷ lệ tăng cân và cải thiện kỹ năng tâm thần vận động (phản ứng nhanh, chính xác) hơn trẻ em thiếu máu dùng placebo. Khi thiếu hụt sắt có thể không chỉ có sự thay đổi sự tạo máu, mà còn thay đổi chức năng của nhiều enzym quan trọng. Do vậy bổ sung sắt là biện pháp rất quan trọng để điều trị thiếu máu nhược sắc.
- Acid folic: Là vitamin thuộc nhóm B. Trong cơ thể, nó được khử thành tetrahydrofolat là coenzyme của nhiều quá trình chuyển hóa trong đó có tổng hợp các nucleotid có nhân purin hoặc pyrimidin; Do vậy ảnh hưởng lên tổng hợp DNA. Khi có vitamin C, acid folic được chuyển thành leucovorin là chất cần thiết cho sự tổng hợp DNA và RNA. Acid folic là yếu tố không thể thiếu được cho tổng hợp nucleoprotein và tạo hồng cầu bình thường; Thiếu acid folic gây ra thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ giống như thiếu máu do thiếu vitamin B₁₂.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sắt fumarat:

- Hấp thu: Khi uống sắt được hấp thu tại tá tràng và phần đầu của hồng tràng khoảng 5 - 10% lượng uống vào cơ thể vận chuyển tích cực. Tỷ lệ này có thể tăng đến 20 - 30% nếu dự trữ sắt bị thiếu hụt hoặc có tình trạng gia tăng sản xuất hồng cầu. Thức ăn, các photphat, phylat có thể làm giảm hấp thu sắt. Các muối sắt II dễ hấp thu hơn các muối sắt III gấp 3 lần.
- Phân bố - chuyển hóa: Sắt được chuyển hóa trong huyết tương dưới dạng transferrin đến dịch gian bào các mô nhất là gan và dự trữ ở dạng ferritin. Sắt được đưa vào tủy đỏ xương để trở thành một thành phần của huyết tố trong hồng cầu, vào trong cơ thể thành một thành phần của myoglobin. Hai nơi dự trữ sắt lớn nhất là hồng cầu và hệ võng nội mô.
- Thải trừ: Sắt được thải trừ khoảng 1 mg/ngày ở nam khỏe mạnh, đa số qua đường tiêu hóa (Mật, tế bào niêm mạc trực, còn lại qua da và nước tiểu; Ở phụ nữ sắt thải thêm qua đường kinh nguyệt có thể đến 2mg/ngày.

Acid folic:

- Hấp thu: Thuốc giải phóng nhanh ở dạ dày và hấp thu chủ yếu ở đầu đoạn ruột non.
- Phân bố - chuyển hóa: Acid folic trong chế độ ăn bình thường được hấp thu rất nhanh và phân bố các mô trong cơ thể. Thuốc được tích trữ chủ yếu ở gan và được tập trung tích cực trong dịch não tủy.
- Thải trừ: Mỗi ngày khoảng 4 - 5 microgam đào thải qua nước tiểu. Uống acid folic liều cao làm lượng vitamin đào thải qua nước tiểu tăng lên theo tỷ lệ thuận. Acid folic đi qua nhau thai và có ở trong sữa mẹ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 06 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

- Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: TCCS.

MEDISUN

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm **ME DI SUN**
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: (0274) 3589 036 - Fax: (0274) 3589 297